

TOSCANA DIAGNOSTICA S.r.l.

Sistema di Gestione Integrato

PROCEDURA PRIMO SOCCORSO E GESTIONE DELL'EMERGENZA MEDICA

Area 05 – Sicurezza

Codice	Revisione	Data	Pagine
TD-SGI-PRO008_01	01	23/07/2026	9
Redatto da	Approvato da	Classificazione	Stato
RSPP / DS	AD – Francesco Epifani	Interno	In vigore

Responsabile del Documento	RSGI	Emissione del Documento
Iacopo Cupelli	Iacopo Cupelli	Francesco Epifani
12/04/2026	12/04/2026	12/04/2026

Sommario

1. Scopo e campo di applicazione.....	3
2. Riferimenti normativi.....	3
3. Termini e definizioni.....	3
4. Classificazione dell'azienda e organizzazione del primo soccorso.....	3
5. Addetti al primo soccorso.....	4
6. Dotazioni e presidi sanitari.....	4
6.1 Cassetta di primo soccorso.....	4
6.2 Defibrillatore semiautomatico (DAE).....	4
7. Emergenze mediche tipiche delle strutture diagnostiche.....	4
7.1 Reazione vasovagale (sincope da prelievo).....	5
7.2 Reazione allergica e anafilassi.....	5
7.3 Arresto cardiaco.....	5
7.4 Crisi epilettica.....	5
7.5 Ipoglicemia.....	6
7.6 Trauma da caduta.....	6
8. Procedura generale di gestione dell'emergenza medica.....	6
9. Comunicazione di emergenza.....	6
10. Gestione post-evento e registrazione.....	7
11. Formazione e addestramento.....	7
12. Verifica e manutenzione dei presidi.....	7
13. Matrice delle responsabilità (RACI).....	7
14. Indicatori di processo.....	8
15. Storico delle revisioni.....	8

1. Scopo e campo di applicazione

La presente procedura disciplina l'organizzazione del servizio di primo soccorso e la gestione delle emergenze mediche in tutte le strutture della rete Toscana Diagnostica. La peculiarità di un'organizzazione sanitaria diagnostica risiede nel fatto che le emergenze mediche possono coinvolgere sia i lavoratori sia i pazienti, e che la presenza di personale sanitario qualificato rappresenta una risorsa immediata che deve essere organizzata e coordinata.

La procedura si applica a tutte le sedi operative (Laboratorio centralizzato, centri diagnostici, punti prelievo, sedi amministrative) e a tutte le persone presenti (dipendenti, collaboratori, pazienti, accompagnatori, visitatori, fornitori). Essa integra e non sostituisce il Piano di Emergenza e di Evacuazione previsto dal D.Lgs. 81/2008, con il quale si coordina.

2. Riferimenti normativi

Norma / Riferimento	Ambito
D.Lgs. 81/2008, artt. 43-46	Gestione delle emergenze, primo soccorso, designazione addetti
DM 388/2003	Regolamento sul pronto soccorso aziendale: classificazione, formazione, dotazioni
D.Lgs. 81/2008, art. 36-37	Informazione e formazione dei lavoratori
Legge 120/2001 e DM 18/03/2011	Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici (DAE) in sede extraospedaliera
Decreto Balduzzi (DL 158/2012)	Diffusione dei DAE nei luoghi pubblici e nei luoghi di lavoro
ISO 45001:2018, cl. 8.2	Preparazione e risposta alle emergenze
ISO 7101:2023	Qualità nelle organizzazioni sanitarie – sicurezza del paziente
TD-SGI-POL001	Politica Integrata del SGI – impegno SSL
TD-SGI-PRO007	Procedura Gestione del Rischio Biologico e Sanificazione

3. Termini e definizioni

Primo soccorso: insieme di interventi, manovre e azioni messi in atto da personale non medico (addetto al primo soccorso) al fine di preservare la vita del soggetto colpito da male o infortunio, in attesa dell'intervento del servizio di emergenza sanitaria (118).

Emergenza medica: situazione imprevista che mette in pericolo la vita o la salute di una persona e che richiede un intervento immediato e coordinato.

Addetto al primo soccorso (APS): lavoratore designato dal datore di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008, formato secondo il DM 388/2003.

DAE: Defibrillatore Automatico Esterno (o semiautomatico), dispositivo in grado di analizzare il ritmo cardiaco e, se necessario, erogare una scarica elettrica per ristabilire il ritmo sinusale.

BLS-D: Basic Life Support and Defibrillation, protocollo di rianimazione cardiopolmonare di base con uso del defibrillatore.

NUE 112 / 118: Numero Unico di Emergenza / Servizio di Emergenza Sanitaria territoriale.

4. Classificazione dell'azienda e organizzazione del primo soccorso

Ai sensi dell'art. 1 del DM 388/2003, Toscana Diagnostica è classificata come azienda di Gruppo B (più di tre lavoratori e attività non rientranti nel Gruppo A). Le strutture sanitarie che effettuano prestazioni con esposizione a rischio biologico o che accolgono pazienti possono essere classificate di Gruppo A qualora previsto dalla valutazione dei rischi. In ogni caso, Toscana Diagnostica adotta il livello organizzativo più elevato, dotando tutte le sedi operative di cassetta di primo soccorso e DAE.

In ogni struttura operativa è garantita la presenza di almeno un addetto al primo soccorso formato per ogni turno di lavoro. Nelle strutture con personale medico o infermieristico in servizio, tale personale costituisce risorsa aggiuntiva qualificata per la gestione delle emergenze mediche.

5. Addetti al primo soccorso

Gli addetti al primo soccorso sono designati dall'Amministratore Delegato su proposta del RSPP, in numero adeguato a garantire la copertura di tutti i turni e di tutte le sedi operative. La designazione tiene conto della distribuzione del personale, degli orari di apertura, della tipologia di attività e della presenza di pazienti. L'elenco nominativo degli APS è affisso nelle bacheche di ciascuna sede, comunicato a tutto il personale e aggiornato in caso di variazioni.

Gli APS sono formati secondo il programma previsto dal DM 388/2003 (12 ore per il Gruppo A, 12 ore per il Gruppo B) con aggiornamento triennale (4 ore). La formazione comprende: riconoscimento dell'emergenza sanitaria, allertamento del 118, interventi di primo soccorso (emorragie, fratture, lesioni spinali, ustioni, avvelenamenti, sincope, arresto cardiaco), tecniche di rianimazione cardiopolmonare (BLS-D). Tutti gli APS sono formati all'uso del DAE con rilascio dell'abilitazione prevista dalla normativa regionale toscana.

6. Dotazioni e presidi sanitari

6.1 Cassetta di primo soccorso

Ogni struttura operativa è dotata di almeno una cassetta di primo soccorso conforme all'Allegato 1 del DM 388/2003. La cassetta contiene: guanti sterili monouso, visiera paraschizzi, flacone di soluzione cutanea di iodopovidone, flacone di soluzione fisiologica, compresse di garza sterile, pinzette, rotolo di cerotto, rotolo di benda orlata, confezione di cotone idrofilo, confezioni di ghiaccio pronto uso, sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari, termometro, forbici, lacci emostatici, coperta isoterma, cannule di Guedel (misure assortite). Nei punti prelievo con presenza di pazienti a rischio di reazione vasovagale è disponibile anche: sfigmomanometro, saturimetro, glucometro con strisce reattive.

La cassetta è collocata in posizione segnalata, facilmente accessibile e nota a tutto il personale. Il contenuto è verificato mensilmente dal responsabile di struttura e reintegrato immediatamente dopo ogni utilizzo.

6.2 Defibrillatore semiautomatico (DAE)

Ogni centro diagnostico e ogni struttura con accesso di pazienti è dotata di un DAE conforme alla Legge 120/2001 e al Decreto Balduzzi. Il DAE è collocato in posizione segnalata con cartellonistica dedicata, accessibile senza chiave e dotato di teca con allarme acustico. La manutenzione del DAE (verifica batteria, scadenza piastre, autotest) è condotta mensilmente dal responsabile di struttura e registrata nel log di manutenzione del dispositivo. Il Laboratorio centralizzato di Sesto Fiorentino e i centri diagnostici principali dispongono di DAE con elettrodi adulto e pediatrici.

7. Emergenze mediche tipiche delle strutture diagnostiche

Le strutture diagnostiche presentano scenari di emergenza medica specifici, che il personale deve essere preparato a riconoscere e gestire tempestivamente.

7.1 Reazione vasovagale (sincope da prelievo)

La reazione vasovagale è l'emergenza più frequente nei punti prelievo e nelle sale prelievo dei centri diagnostici. Si manifesta con pallore, sudorazione, nausea, visione offuscata e può evolvere in perdita di coscienza transitoria:

- Riconoscere i segni premonitori: pallore, sudorazione fredda, nausea, senso di mancamento.
- Far sdraiare il paziente o, se seduto, abbassare la testa tra le ginocchia. Sollevare gli arti inferiori (posizione di Trendelenburg).
- Allentare indumenti stretti. Garantire areazione dell'ambiente.
- Monitorare i parametri vitali (frequenza cardiaca, pressione arteriosa, saturazione O₂ se disponibile saturimetro).
- In caso di perdita di coscienza: verificare la pervietà delle vie aeree, posizionare in posizione laterale di sicurezza, chiamare il 118 se la ripresa non avviene entro 2 minuti.
- Non somministrare liquidi o alimenti a paziente non completamente vigile.
- Trattenere il paziente nella struttura per almeno 15 minuti dopo la ripresa completa.

7.2 Reazione allergica e anafilassi

Le reazioni allergiche possono verificarsi in seguito alla somministrazione di mezzi di contrasto (diagnostica per immagini), all'uso di guanti in lattice o al contatto con materiali sanitari:

- Reazione lieve (orticaria, prurito localizzato): monitorare il paziente, sospendere l'esposizione all'allergene, allertare il medico presente nella struttura.
- Reazione moderata (edema diffuso, dispnea lieve, orticaria generalizzata): allertare immediatamente il medico e il 118; posizionare il paziente semiseduto; preparare l'adrenalina autoiniettabile se disponibile.
- Anafilassi (dispnea grave, ipotensione, edema della glottide, shock): chiamare immediatamente il 118; somministrare adrenalina autoiniettabile (0,5 mg IM nella coscia anterolaterale) se personale medico presente e farmaco disponibile; posizione supina con arti inferiori sollevati (salvo dispnea: semiseduto); monitorare parametri vitali; predisporre accesso venoso se personale infermieristico presente; prepararsi alla RCP.

7.3 Arresto cardiaco

L'arresto cardiaco è l'emergenza più grave. La sopravvivenza dipende dalla rapidità dell'intervento

Adulto

- Verificare lo stato di coscienza (chiamare ad alta voce, scuotere delicatamente le spalle) e la respirazione (GAS: Guarda, Ascolta, Senti per 10 secondi).
- Se il soggetto è incosciente e non respira normalmente: chiamare immediatamente il 118 e chiedere il DAE.
- Iniziare la RCP: 30 compressioni toraciche (frequenza 100-120/min, profondità 5-6 cm) alternate a 2 ventilazioni di soccorso.
- Appena disponibile il DAE: accenderlo, applicare le piastre adesive, seguire le istruzioni vocali del dispositivo. Non toccare il paziente durante l'analisi e l'eventuale scarica.
- Proseguire la RCP fino all'arrivo del 118 o fino alla ripresa del paziente. Non interrompere le compressioni se non per la ventilazione, l'analisi del DAE o la ripresa della vittima.

Età pediatrica (lattante < 1 anno e bambino da 1 anno alla pubertà)

Nel bambino e nel lattante l'arresto è quasi sempre di origine respiratoria (ipossia): per questo la sequenza si apre con le ventilazioni e il torace si comprime con minore profondità.

- Verificare lo stato di coscienza e la respirazione come nell'adulto; nel lattante stimolare delicatamente la pianta dei piedi anziché scuotere le spalle.
- Se il soggetto è incosciente e non respira normalmente, effettuare subito 5 ventilazioni di soccorso iniziali. Nel lattante coprire con la bocca sia naso sia bocca; nel bambino chiudere il naso e ventilare bocca-a-bocca. Insufflare con volume sufficiente a sollevare visibilmente il torace, senza eccedere.

- Quindi iniziare la RCP con rapporto 15 compressioni : 2 ventilazioni (frequenza 100-120/min, profondità pari ad almeno 1/3 del diametro antero-posteriore del torace: circa 4 cm nel lattante e circa 5 cm nel bambino, lasciando riespandere completamente il torace tra una compressione e l'altra).
- Lattante: compressioni con la tecnica dei due pollici che abbracciano il torace (mani che circondano la gabbia toracica), sul terzo inferiore dello sterno.
- Bambino: compressioni con il palmo di una mano (o di entrambe nei bambini più grandi) sul terzo inferiore dello sterno.
- Se si è da soli e l'arresto non è stato testimoniato, eseguire 1 minuto di RCP prima di allertare il 118 (se possibile col vivavoce, senza abbandonare il bambino); in caso di collasso improvviso testimoniato, allertare immediatamente il 118 e chiedere il DAE.
- Appena disponibile il DAE: utilizzarlo seguendo le istruzioni vocali. Sotto gli 8 anni impiegare, se disponibili, piastre pediatriche o l'attenuatore di energia; se non disponibili, usare comunque il DAE per adulti, che può essere impiegato a qualsiasi età, lattante incluso. Posizionare le piastre in modo che non si tocchino (nel lattante, una sul torace anteriore e una sul dorso).
- Proseguire la RCP fino all'arrivo del 118 o alla ripresa del paziente, interrompendo le compressioni solo per le ventilazioni, l'analisi del DAE o la ripresa della vittima.

7.4 Crisi epilettica

- Proteggere il paziente da traumi: allontanare oggetti pericolosi, non tentare di bloccare i movimenti, non introdurre nulla in bocca.
- Annotare l'ora di inizio e la durata della crisi. Chiamare il 118 se la crisi dura più di 5 minuti o se è la prima crisi nota.
- Al termine della crisi: posizione laterale di sicurezza, monitorare respiro e coscienza, assistere il paziente nella ripresa.

7.5 Ipoglicemia

- Riconoscere i sintomi: tremori, sudorazione, confusione, irritabilità, pallore. Misurare la glicemia con il glucometro se disponibile.
- Paziente cosciente: somministrare zucchero a rapido assorbimento (succo di frutta, caramelle, bustine di zucchero).
- Paziente incosciente: non somministrare nulla per via orale; posizione laterale di sicurezza; chiamare il 118.

7.6 Trauma da caduta

- Non spostare il paziente se si sospetta un trauma spinale o cranico.
- Controllare e fermare eventuali emorragie con compressione diretta con garza sterile.
- Immobilizzare eventuali fratture nella posizione in cui si trovano. Chiamare il 118. Applicare ghiaccio pronto uso su contusioni ed edemi.

8. Procedura generale di gestione dell'emergenza medica

La gestione dell'emergenza medica segue un protocollo strutturato in fasi:

Fase 1 – Riconoscimento e allertamento: chi rileva l'emergenza valuta rapidamente la scena (sicurezza, numero di persone coinvolte, tipo di emergenza), allerta l'addetto al primo soccorso più vicino e, se necessario, chiama il NUE 112.

Fase 2 – Primo intervento: l'APS o il personale sanitario presente attua le manovre di primo soccorso appropriate allo scenario (vedi Sezione 7), garantendo la sicurezza propria e del paziente.

Fase 3 – Coordinamento: il responsabile di struttura coordina le operazioni: designa un incaricato per accogliere il mezzo di soccorso all'ingresso, assicura l'accesso libero per la barella, allontana le persone non coinvolte.

Fase 4 – Affidamento ai soccorsi: all'arrivo del 118, l'APS o il medico presente trasferiscono le informazioni rilevanti (cosa è accaduto, interventi effettuati, parametri rilevati, anamnesi nota).

Fase 5 – Post-evento: compilazione del modulo di registrazione dell'evento, comunicazione al RSPP, al Direttore Sanitario e al Medico Competente, analisi dell'evento e identificazione di azioni di miglioramento.

9. Comunicazione di emergenza

Ogni struttura operativa espone in posizione visibile il cartello con i numeri di emergenza e le informazioni per la chiamata al 118. Alla chiamata al NUE 112 l'operatore deve comunicare: la natura dell'emergenza (malore, arresto cardiaco, caduta, reazione allergica); il luogo esatto (indirizzo completo della struttura, piano, stanza); il numero di persone coinvolte e le loro condizioni; gli interventi già effettuati; il proprio nome e un numero di telefono per il ricontatto. Non riagganciare fino a quando l'operatore della centrale non lo chiede.

10. Gestione post-evento e registrazione

Ogni emergenza medica è registrata nel Registro degli Eventi di Primo Soccorso, che contiene: data, ora e luogo dell'evento; soggetto coinvolto (lavoratore, paziente, visitatore); dinamica dell'evento; interventi effettuati; operatori intervenuti; esito (risoluzione in sede, trasporto in PS, ricovero); eventuali azioni correttive. Se l'evento coinvolge un lavoratore, il RSPP valuta se configurare l'evento come infortunio sul lavoro ai fini della denuncia obbligatoria (INAIL). Se l'evento coinvolge un paziente, il Direttore Sanitario valuta l'eventuale segnalazione come evento avverso ai sensi della ISO 7101. Il registro è conservato per 10 anni ed è disponibile per il Medico Competente, il RSPP e l'RSGI.

11. Formazione e addestramento

La formazione sul primo soccorso è obbligatoria e articolata come segue:

Corso	Destinatari	Durata	Rinnovo	Normativa
Primo soccorso DM 388	APS designati	12 ore	Ogni 3 anni (4h)	DM 388/2003
BLS-D e uso DAE	APS + personale sanitario	8 ore	Ogni 2 anni	DM 18/03/2011, LR Toscana
Gestione emergenze specifiche	Personale punti prelievo e centri	4 ore	Annuale	ISO 45001 cl. 8.2
Simulazione emergenza medica	Tutto il personale	2 ore	Annuale	ISO 45001 cl. 8.2
Informazione generale primo soccorso	Tutti i lavoratori	1 ora (induction)	All'assunzione	D.Lgs. 81/2008 art. 36

12. Verifica e manutenzione dei presidi

Il responsabile di struttura effettua le seguenti verifiche periodiche:

Presidio	Verifica	Frequenza	Registrazione
Cassetta di primo soccorso	Completezza contenuto, scadenze materiali	Mensile	Checklist datata e firmata
DAE	Autotest, stato batteria, scadenza piastre	Mensile	Log manutenzione dispositivo

Adrenalina autoiniettabile	Scadenza, integrità confezionamento	Mensile	Registro farmaci
Saturimetro / Sfigmomanometro	Funzionamento, taratura	Semestrale	Registro apparecchiature
Cartellonistica emergenza	Integrità, visibilità, aggiornamento numeri	Trimestrale	Checklist
Spill kit biologico	Completezza, integrità materiali	Trimestrale	Checklist (cross-ref PRO007)

13. Matrice delle responsabilità (RACI)

R = Responsabile, A = Approvatore, C = Consultato, I = Informato.

Attività	RSP	DS	Resp.str.	APS	MC	RSGI
Designazione APS	R	C	I	I	C	I
Formazione primo soccorso	R	C	I	R	C	I
Dotazione cassetta / DAE	R	A	R	I	C	I
Verifica mensile presidi	I	I	R	C	I	I
Intervento in emergenza	C	C	C	R	I	I
Chiamata 118	I	I	R	R	I	I
Registrazione post-evento	R	I	R	C	I	R
Analisi evento e azioni correttive	R	C	C	I	C	R
Reporting e flussi OdV	I	I	I	I	I	R

14. Indicatori di processo

Copertura APS per turno: percentuale di turni con almeno un APS presente. Obiettivo: 100%.

Completezza formazione APS: percentuale di APS formati e con abilitazione in corso di validità. Obiettivo: 100%.

Abilitazione BLS-D in corso di validità: percentuale di APS con abilitazione DAE valida. Obiettivo: 100%.

Conformità presidi (audit mensile): percentuale di verifiche mensili con esito conforme. Obiettivo: 100%.

Tempo medio di intervento (dalla segnalazione al primo intervento): obiettivo: entro 3 minuti.

Simulazioni effettuate: numero di simulazioni di emergenza medica condotte per anno. Obiettivo: almeno 1 per struttura.

Eventi registrati: numero di emergenze mediche gestite per trimestre, classificate per tipologia, esito e sede.

15. Storico delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione modifiche	Approvazione
00	12/04/2026	Prima emissione	Francesco Epifani
01	29/06/2026	Seconda emissione	Francesco Epifani